

16. Typologies des régimes alimentaires

I. Panorama des régimes santé

1. Le régime méditerranéen
2. Le régime paléo

II. Les régimes Low Carb

1. Le nouveau régime Atkins
2. Le régime cétogène
3. Ce qu'en dit la recherche

III. Les régimes hypotoxiques

1. Le régime GASP
2. Le régime anti-inflammatoire
3. Le protocole AIP
4. Le protocole Wahls

Objectifs du cours

- Connaître les régimes alimentaires les plus couramment utilisés actuellement pour être en mesure de les recommander
- Ces régimes proposent de corriger des dysfonctionnements de l'organisme métaboliques, troubles du SN, douleurs chroniques, inflammations, troubles digestifs
- Certains de ces régimes présentés dans ce panorama seront revus en nutrition appliquée

I. Panoramas des régimes santé

1. Le régime méditerranéen

- Le régime méditerranéen a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO
 - Regroupe les habitudes alimentaires traditionnelles de plusieurs pays méditerranéens, du Portugal au Moyen-Orient en passant par la Croatie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, l'Italie ou le Maghreb

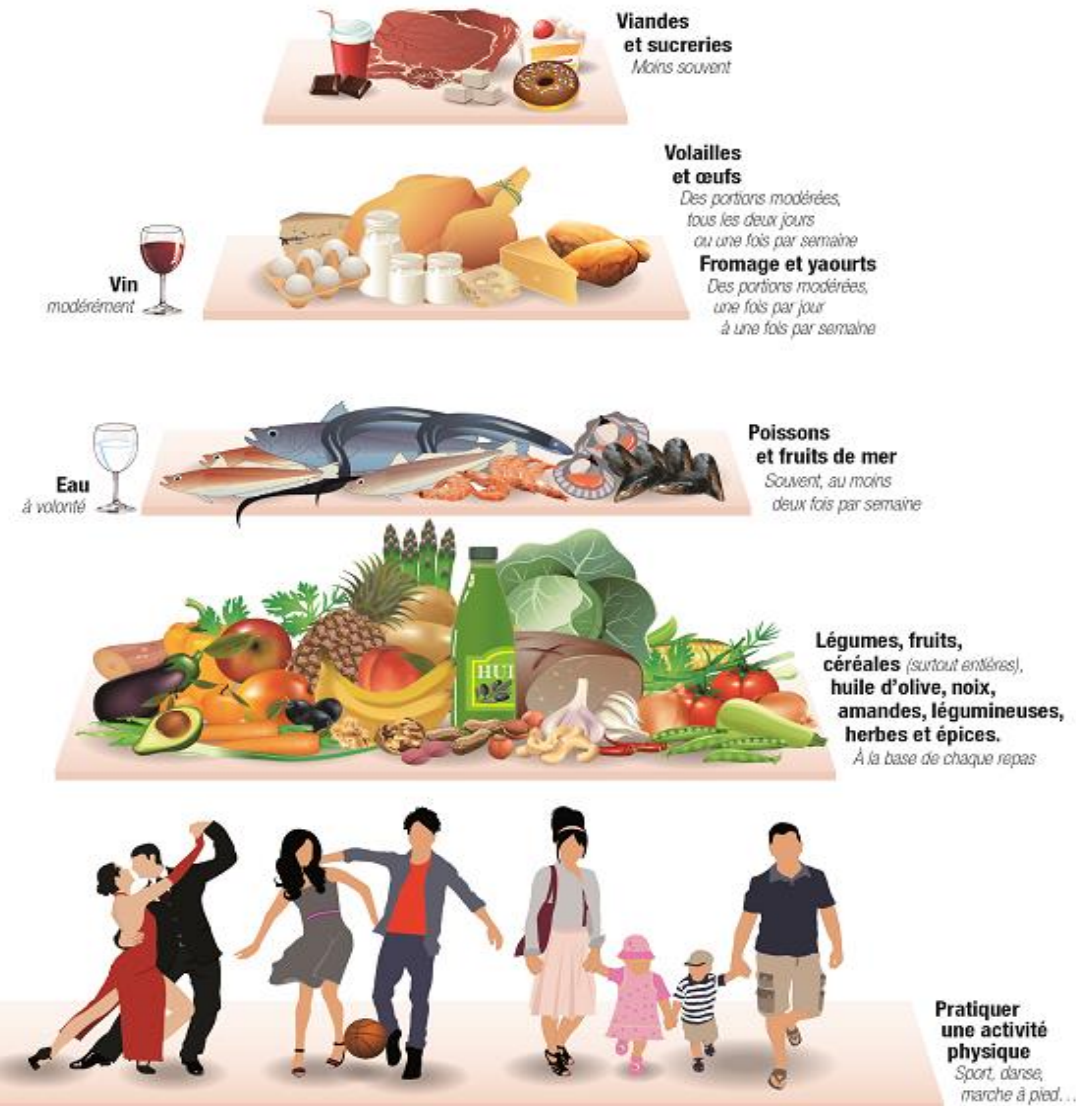


Le régime méditerranéen

- Une quantité importante d'huile d'olive, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, noix et graines
- Un apport régulier de poissons, de crustacés,
- Un apport modéré de viande blanche, œufs, produits laitiers fermentés et vin rouge
- Une faible consommation de viande rouge ou transformée et d'aliments riches en sucres ajoutés

La pyramide du régime méditerranéen

*Une approche contemporaine
d'une alimentation savoureuse et saine*



2. Le régime paléo

- Le régime paléolithique vise à revenir à **l'alimentation de nos ancêtres**, avant l'ère industrielle.
- L'alimentation paléo serait, plus adaptée à nos **besoins physiologiques**.
- Pendant la période du Paléolithique, les seuls aliments qui étaient disponibles étaient ceux issus de **la chasse, la pêche et la cueillette**, ils étaient donc **naturels et frais**.
- La fraîcheur des aliments consommés au Paléolithique, permettait à l'humain de l'époque de garantir une **densité nutritionnelle maximale**

L'alimentation paléo

- Régime à base de végétaux
 - deux tiers de l'assiette composée d'aliments à base de végétaux
 - et un tiers d'aliments d'origine animale

Les aliments autorisés

Viandes, poissons, œufs

Légumes et fruits

Graisses

Boissons



Les aliments éliminés

Toutes les céréales

Tous les produits laitiers

Les légumineuses

Les aliments transformés



II. Les régimes low carb

www.lanutrition.fr

« Low carb" = Low carbohydate = pauvre en glucides

Les régimes "low carb"

- **Du début du 19e siècle à la fin des années 60**
 - Médecins et scientifiques ont été d'accord pour affirmer, preuves à l'appui, que le seul moyen efficace de maigrir lorsqu'on est sédentaire,
 - Diminuer la ration de féculents: *pain, pâtes, riz, pommes de terre,*
 - Limiter les sucres
- **Au début des années 1970,** les nutritionnistes défendent l'idée que
 - Les graisses sont les responsables du surpoids
- **Selon LaNutrion.fr,**
 - Ces recommandations seraient en partie responsables de **l'augmentation ces dernières années des cas d'obésité et de diabète dans la population**

- **Réduire les glucides**

- Veiller à la quantité de glucides consommés par jour
- Pas besoin de compter les calories
- Privilégient une nourriture saine
 - Repas équilibrés
 - Riche en aliments à valeur nutritive élevée
- Ces choix nutritionnels entraînent l'organisme à brûler davantage de graisses

Régimes Low-Carb: Pour qui ?

- **Les problèmes de santé métabolique**

- Syndrome métabolique
- Surpoids
- Obésité
- HTA
- Diabète de type 2
- Stéatose hépatique
- SOPK
- Goutte
- Maladies cardiovasculaires

La perte de poids

Régimes Low-Carb: Les grands principes

- **Objectifs**

- Réduire la glycémie
- Réduire l'insulinémie
- Renverser la résistance à l'insuline et les marqueurs de dysfonction métabolique
- Permettre une meilleure lipolyse
- Augmenter la flexibilité métabolique
- Réduire la résistance à la leptine

1. Le nouveau régime Atkins

Lanutrition.fr

Le nouveau régime Atkins

Le régime Atkins

- **Régime imaginé par le Dr Robert Coleman Atkins (1930-2003), médecin et nutritionniste américain**
- En 1972, le Dr Atkins met au point un programme basé sur :
 - L'élimination par les urines et par la respiration des cétones, des composés carbonés produits par la combustion des graisses
 - Pour produire des cétones, il faut commencer par **supprimer tous les glucides de l'alimentation** de telle sorte que ce soit la graisse stockée qui serve de combustible à l'organisme et non plus les sucres ingérés
 - Impose la mesure des cétones dans les urines
- **Le nouveau régime Atkins (2011) (Dr E Westman, S Phinney et J Volek)**
 - Nouvelle version de ce régime, plus facile à suivre et corrigée des excès de la version d'origine
 - **Régime pauvre en glucides, sans limitation de calories**
 - Aliments à densité nutritionnelle élevée
 - protéines maigres,
 - grande variété de fruits et légumes riches en fibres
 - des lipides riches en AGs polyinsaturés, monoinsaturés
 - limitant les sucres et glucides raffinés
- Inutile de mesurer le taux de cétones dans les urines
- Pas de sensation de faim, pas de comptage des calories, pas de déficit nutritionnel

Les quatre phases du nouveau régime Atkins

- **Phase 1 : phase de démarrage**

- Dure 2 semaines minimum, peut être prolongée si la personne a beaucoup de poids à perdre
- Le corps s'adapte en brûlant préférentiellement les graisses ce qui déclenche la perte de poids

- **Consommation de glucides limitée à 20 g/jour**

- 12 à 15 g de ces glucides doivent provenir de légumes non féculents :
 - légumes à feuilles vertes, salades
- Éviction de tous les aliments contenant du sucre:
 - Céréales sous quelque forme que ce soit,
 - Fruits riches en glucides, jus de fruits et concentrés
- Snack à 10 h et 16 h autorisé (Atkins bars)



- **Phase 2 : phase de perte de poids continue**

- Ajout dans l'alimentation de
 - légumes riches en glucides comme les tomates, les poivrons et les carottes,
 - baies, noix, graines, quelques légumineuses...



- La **consommation journalière de glucides est augmentée par paliers de 5 g** jusqu'à trouver l'équilibre,
 - Seuil glucidique pour la perte de poids : ne doit pas freiner la perte de poids

- **Phase 3 : phase de préstabilisation**
- La gamme des aliments glucidiques est élargie
 - Autres fruits, féculents, céréales complètes
- La **consommation journalière de glucides est augmentée par paliers de 10 g**, tant que la perte de poids continue
- Lorsque la personne approche du poids visé,
 - Tester la quantité de glucides qu'elle peut consommer sans reprendre de poids
 - Seuil d'équilibre glucidique Atkins
 - Quand le poids est stabilisé pendant au moins 1 mois, on passe à la phase 4

Quantité de glucides nets pour une portion de 100 g		
FRUITS		Banane 21 g
		Raisins 17 g
		Mangue 13 g
		Pomme 12 g
		Ananas 11 g
		Orange 10 g
		Framboises 5 g
PRODUITS CÉRÉALIERS		Pain blanc 46 g
		Pâtes alimentaires cuites 30 g
		Riz blanc cuit 29 g
NOIX ET ARACHIDES		Noix de cajou 27 g
		Pistaches 19 g
		Arachides 13 g
		Amandes 10 g
		Noix de Grenoble 7 g
		Pacanes 4 g
LÉGUMINEUSES CUITES		Lentilles 16 g
		Haricots rouges 13 g
		
LÉGUMES		Mais 19 g
		Pomme de terre bouillie 18 g
		Patate douce bouillie 15 g
		Panais 15 g
		Carotte 8 g
		Betterave 7 g
		Céleri-rave 5 g
		Poivron jaune 5 g
		Chou-fleur 3 g
		Courgette 2 g
		Asperges 2 g

- **Phase 4 : phase de stabilisation définitive**
- Consommation des aliments variés de la phase 3
- Surveillance de son poids à vie
- Chaque personne doit apprendre à gérer elle-même son poids,
 - certaines personnes vont devoir continuer à consommer peu de glucides (personnes sensibles)
 - d'autres vont pouvoir élargir la gamme des aliments glucidiques (personnes tolérantes).



PHASE 1

20-25g
Glucides nets
par jour

PHASE 2

25-50g
Glucides nets
par jour

PHASE 3

50-80g
Glucides nets
par jour

PHASE 4

80-100g
Glucides nets
par jour

ALIMENTS PERMIS:

LÉGUMES DE BASE, PROTÉINES, BON
GRAS ET LA PLUPART DES FROMAGES

NOIX ET GRAINES

PETITS FRUITS, CERISES OU MELONS

YOGOURT GREC DE LAIT ENTIER,
RICOTTA OU FROMAGE COTTAGE

LÉGUMINEUSES

JUS DE TOMATE

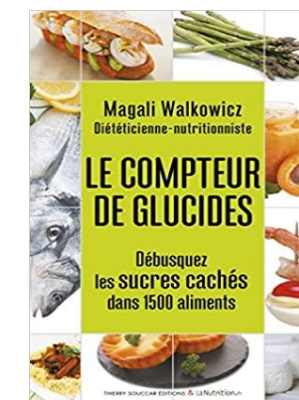
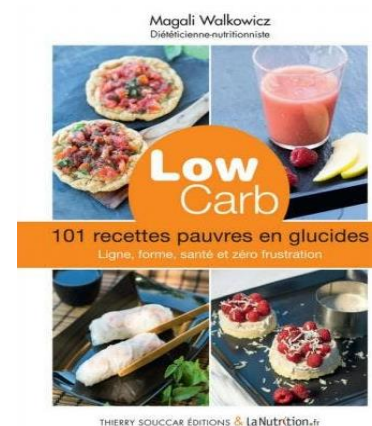
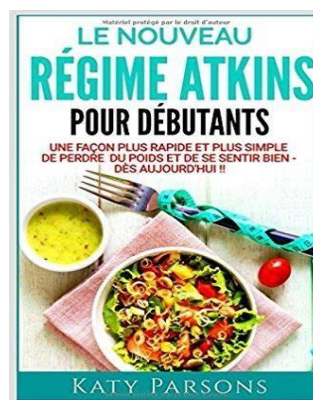
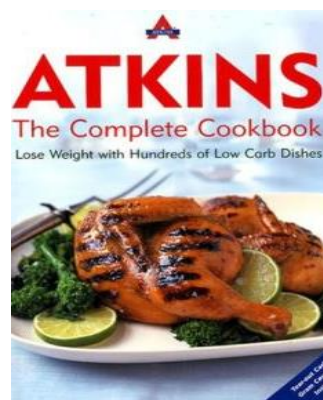
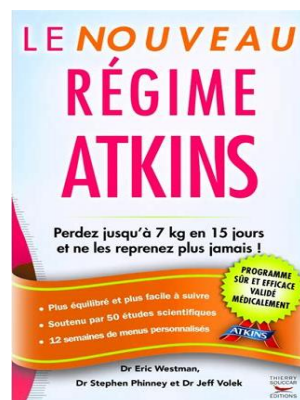
AUTRES FRUITS

LÉGUMES FÉCULENTS

GRAINS ENTIERS



RÉGIME	NOUVEAU RÉGIME ATKINS
Points forts	Relativement facile à suivre Effets amaigrissants rapides Pas de fringales
Points faibles	Dans l'ancienne version, risque de constipation et de fatigue. (résolus)
Recommandations LaNutrition.fr	On peut manger varié (des protéines, des bonnes graisses, des légumes, des noix, des baies...) et cela sans limitation de calories Seuls les glucides doivent faire l'objet d'une attention particulière. Moins frustrant qu'un régime pauvre en graisses, plus sain, plus efficace à long terme Reste la question du comptage des glucides: Contraignant au début, il faut un peu de temps pour prendre ses marques



2. Le régime cétogène

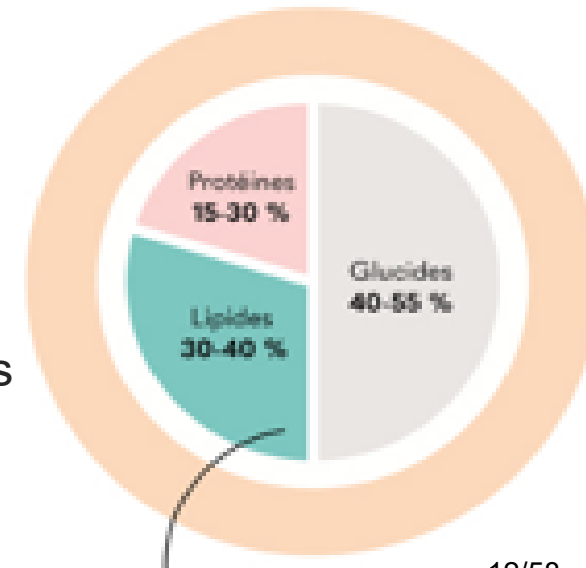
Le régime cétogène ou kéto (ou Low Carb High Fat, LCHF)

- **Permet à l'organisme de tirer l'énergie nécessaire** à son fonctionnement d'une autre source que **les glucides**
 - Les corps cétoniques sont fabriqués par le foie, à partir des acides gras
- **Restreint fortement les glucides par rapport à une alimentation normale**
 - 0 à 20 g de glucides par jour
 - Plus si activité physique élevée
 - Privilégie les lipides
 - Garde une teneur en protéines modérée

Le régime cétogène

- **Combien de glucides par jour dans un régime cétogène ?**
 - 70 à 80% de lipides,
 - 20 à 25% de protéines
 - 5 à 10% de glucides (20 à 50 grammes de glucides par jour)
- LaNutrition.fr recommande depuis 2006 les pourcentages d'apports caloriques suivants

Répartition des macro-nutriments



Différents cétoènes

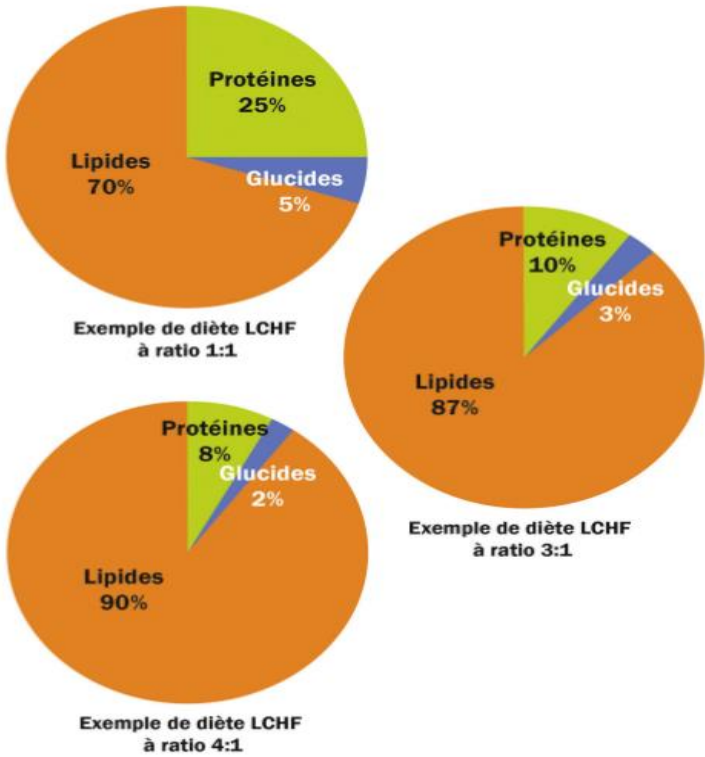
- **Les restrictions glucidiques**
 - Selon les objectifs (santé, minceur, forme) et l'activité physique
 - **Cétogène strict :**
 - < 20 g de glucides/jour
 - **Cétogène modéré :**
 - < 50 g de glucides/jour
- Seules comptent les teneurs en glucides et lipides, on oublie les calories
 - Se munir d'un compteur de glucides
 - Connaître la teneur en glucides des aliments courants

Les ratios cétoènes

- Ratio cétoène 4:1
 - 4 parts de graisses pour 1 part de protéines + glucides

Ratios	Graisses (% des calories)	Graisses (% en grammes)	Glucides + protéines (% des calories)	Glucides + protéines (% en grammes)
1:1	70	50	30	50
2:1	82	67	18	33
3:1	87	75	13	25
4:1	90	80	10	20

En % des calories



Exemples de ratios cétoènes

Aliments autorisés : Légumes

Tous les légumes dont
la **teneur en glucides**
est inférieure à 5
g/100 g

Les **petits fruits à IG**
bas ou fruits acides

Huiles, beurre,
graisses animales,
triglycérides à
chaîne moyenne
• Huile ou crème TCM C8 C10

Produits laitiers
animaux

Boissons végétales

Viandes, Poissons,
Œufs (bio)

Noix modérément et
Graines

Boissons non
sucrées

Les aliments interdits en cétogène



AUT

plats industriels, pizzas, charcuteries industrielles,...



Féculents

tubercules riches en amidon: pommes de terre, patates douces
pâtes, riz et **autres céréales** et leurs dérivés (semoule, farine ...)
pain sous toutes ses formes



Fruits

plus de 7g de glucides/100g
majorité des fruits: pomme, orange, poire, raisin, etc.



Boissons sucrées

Sodas et jus de fruits
Alcools



Sucre et produits sucrés

sucre de table, confitures, biscuits, pâtes à tartiner, miel, sirop d'érable, sucre de coco...



Snacks sucrés

barres de céréales, au chocolat, pâtes de fruit, chocolat à moins de 85% de cacao, viennoiseries



Bonbons, chocolats et autres confiseries

Chocolats à 85%, 90% ou 100% de cacao autorisés



Laitages sucrés ou light et desserts lactés



Desserts industriels ou artisanaux

sauf ceux faits maison qui obéissent aux règles de ce régime

RÉGIME CÉTOGÈNE KETO

Points forts

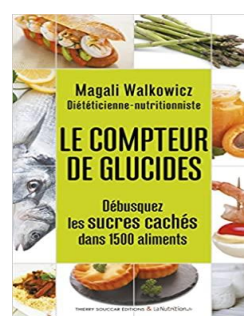
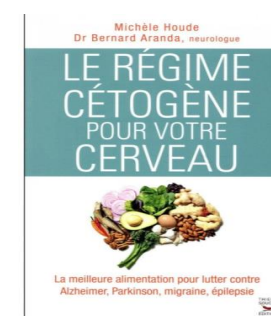
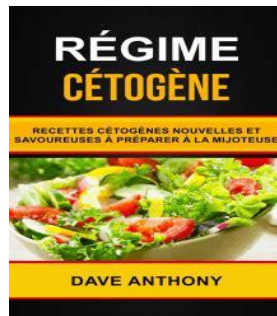
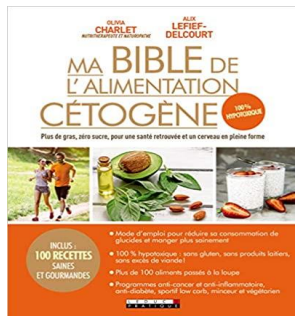
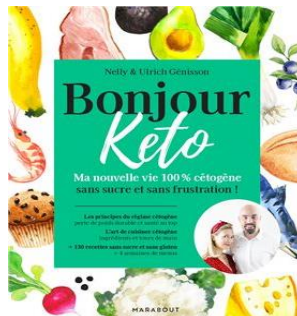
Satiété
Perte de poids rapide par mobilisation des graisses corporelles (lipolyse)

Points faibles

Déficit possible en certains minéraux et vitamines lorsque le régime est strict
Constipation,
Augmentation du risque de calcul rénal potentielle
Risque d'élévation du LDL chez certains
Le comptage des glucides est contraignant au début, il faut un peu de temps
Complexe, contraignant

Recommandations LaNutrition.fr

On peut manger varié (protéines, bonnes graisses, légumes, noix, baies...) sans limitation de calories.
Seuls les glucides doivent faire l'objet d'une attention particulière.



3. Le point de vue de la recherche

Les études: Low carb et diabète

- Le régime low carb a souvent conduit à des améliorations importantes des **taux de glucose et de lipides sanguins chez les diabétiques de type 2.**
- **Une revue des études publiée en 2018 dans l'European Journal of Clinical Nutrition**
 - A montré les effets positifs du régime low carb sur l'hémoglobine glyquée HbA1c .
 - Un régime pauvre en glucides (low carb) améliorerait aussi la fonction rénale.
- D'autres études ont montré qu'il était possible de **réduire, voire d'éliminer les médicaments anti-diabète** grâce à une consommation limitée de glucides.
- Le régime low carb permet de réduire les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires
 - Perte de poids, baisse de la glycémie, des triglycérides, de la pression artérielle quand il y a hypertension.

L'interprétation et l'effet d'un régime pauvre en glucides dans la prise en charge du diabète de type 2 : une revue systématique et une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés

Romarin Huntriss ¹, Malcom Campbell ², Carole Bedwell ²

Affiliations + développer

PMID : 29269890 DOI : 10.1038/s41430-017-0019-4

Résumé

Contexte/objectifs : Récemment, le rôle d'un régime pauvre en glucides dans la gestion du diabète a suscité de l'intérêt avec des allégations concernant sa supériorité sur l'approche alimentaire traditionnelle riche en glucides et faible en gras. Cette revue systématique et méta-analyse a évalué l'interprétation et l'effet d'un régime pauvre en glucides dans la prise en charge du diabète de type 2.

Sujets/méthodes : les essais contrôlés randomisés ont été recherchés et incluaient des adultes atteints de diabète de type 2 âgés de 18 ans ou plus. L'intervention était un régime pauvre en glucides tel que défini par l'auteur par rapport à un groupe témoin de soins habituels. MEDLINE, EMBASE, CINAHL, le registre Cochrane des essais contrôlés, ISRCTN, ProQuest et opengrey.eu ont été consultés. Des experts indépendants ont été contactés et les listes de références des articles sélectionnés ont été vérifiées. Les résultats ont été analysés de manière descriptive et des méta-analyses ont été réalisées pour inclure les essais présentant des données à 1 an.

Résultats : Dix-huit études (n = 2 204) étaient éligibles pour l'inclusion dans la revue systématique. La

définition d'un régime pauvre en glucides variait. À la fin de l'essai, l'analyse descriptive a suggéré que le bras d'intervention à faible teneur en glucides (LCIA) pouvait favoriser des résultats favorables en termes d'HbA1c, de triglycérides et de cholestérol HDL. Le LCIA a démontré des besoins réduits en médicaments contre le diabète, ce qui peut avoir réduit le bénéfice observé de la restriction alimentaire en glucides sur l'HbA1c. Sept études ont fourni des données à inclure dans les méta-

analyses à 1 an. Les méta-analyses ont montré une signification statistique en faveur du LCIA pour

l'HbA1c (effet estimé = -0,28 %, IC à 95 % -0,53 à -0,02, p = 0,03 ; $\chi^2 = 13,15$, df = 6, p = 0,03 ; $I^2 = 54$ %), cholestérol HDL (effet estimé = 0,06 mmol/L, IC 95 % 0,04-0,09, p < 0,00001 ; $\chi^2 = 6,05$, df = 6, p = 0,42 ; $I^2 = 1$ %), triglycérides (estimation effet = -0,24 mmol/L, IC 95 % -0,35 à -0,13, p < 0,0001 ; $\chi^2 = 1,88$, df = 6, p = 0,93 ; $I^2 = 0$ %) et tension artérielle systolique (effet estimé = -2,74 mmHg, IC à 95 % -5,27 à -0,20, p = 0,03 ; $\chi^2 = 10,54$, df = 6, p = 0,10 ; $I^2 = 43$ %). Les méta-analyses pour le poids, le cholestérol total, le cholestérol LDL et la tension artérielle diastolique n'ont pas démontré de différence statistiquement significative entre les interventions. L'observance alimentaire était un problème dans la plupart des études. Un régime très pauvre en glucides (<50 g/jour) semble irréaliste dans cette population, cependant, un régime pauvre en glucides (<130 g/jour) semble réalisable. Des résultats cliniques améliorés ont été observés dans certaines études à la suite de la réalisation d'un régime alimentaire faible ou modéré en glucides. Quinze études sur 18 étaient considérées comme présentant un risque élevé de biais, le biais de performance étant un problème courant.

Conclusions : La réduction des glucides alimentaires peut entraîner des améliorations cliniques dans la prise en charge du diabète de type 2. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le véritable effet de la restriction alimentaire en glucides sur l'HbA1c indépendamment de la réduction des médicaments et pour résoudre les problèmes connus liés à l'adhésion à cette intervention alimentaire. La clarté est nécessaire concernant la classification appropriée d'un régime pauvre en glucides.

La migraine se caractérise par des crises récurrentes de céphalées invalidantes, souvent accompagnées de troubles sensoriels et moteurs. Les manifestations cliniques de la migraine sont influencées par les comportements alimentaires et les éléments alimentaires. Plusieurs déclencheurs alimentaires de la migraine ont été identifiés, conduisant à la définition de stratégies telles que les régimes d'élimination, les régimes **cétogènes** et les régimes complets, principalement pour aider à prévenir la migraine. Bien que des incohérences soient présentes dans la littérature et qu'aucun consensus n'existe, les données disponibles sont prometteuses pour soutenir les interventions diététiques bénéfiques pour certains patients migraineux. Plusieurs facteurs influencent le résultat net, notamment l'âge, le sexe, la génétique et les facteurs environnementaux. Les progrès dans la compréhension des mécanismes sous-jacents de la pathogenèse de la migraine et de la manière dont les facteurs alimentaires peuvent interférer avec ces mécanismes ont encouragé les chercheurs à considérer le régime comme un agent modificateur de la maladie, qui peut également interférer avec l'axe intestin-cerveau ou l'épigénétique de la migraine. Les travaux futurs recèlent un potentiel pour le phénotypage des patients migraineux et l'offre de recommandations personnalisées conformes aux modèles biopsychosociaux pour la prise en charge de la migraine. L'alimentation, en tant qu'élément important du mode de vie, est un aspect modifiable qui nécessite une attention particulière. Des recherches diététiques bien conçues, systématiques et axées sur les mécanismes sont nécessaires pour fournir des recommandations diététiques fondées sur des preuves spécifiques à la migraine. Cette revue narrative vise à présenter l'état actuel et les perspectives futures sur l'alimentation et la migraine,

Mots-clés : alimentation ; modification de la maladie ; épigénétique; mal de tête; migraine; la nutrition; déclencheurs.

Migraine et alimentation

Parisa Gazerani ¹

Affiliations + développer

PMID : 32503158 PMCID : PMC7352457 DOI : 10.3390/nu12061658

Article PMC gratuit

Etude: Low carb et migraine

- **Etude parue dans la revue JAMA Pediatrics en 2020,**
- Portant sur 3 régimes alimentaires : Atkins modifié, index glycémique (IG) bas et cétogène
 - Démontrer que les 2 premiers régimes pouvaient être aussi efficaces que le régime cétogène pour réduire la fréquence des crises des enfants épileptiques qui ne répondent pas aux médicaments
 - L'efficacité du régime cétogène pour soulager l'épilepsie a été montrée, mais celui-ci peut être difficile à suivre et présente des effets indésirables.
- Dans cet essai contrôlé randomisé, 170 enfants âgés de 1 à 15 ans et ayant au moins 4 crises d'épilepsie par mois ont suivi
 - soit le régime cétogène, soit le régime Atkins modifié, soit un régime à index glycémique bas
 - pas d'aliment à IG supérieur à 55, part de glucides : 10% des calories quotidiennes
 - en plus du traitement médicamenteux
- Les résultats montrent qu'après **24 semaines de régime**, la **fréquence des crises a diminué** dans les trois groupes

152 enfants	Cétogène	Nouvel Atkins	IG bas
Réduction des crises d'épilepsie	66%	45%	54%
Diminution de crises d'épilepsie d'au moins 50%	67,3%	51,9%	Moins nombreux
Effets indésirables	38,2%	41,4%	24,6%

- Les effets indésirables étaient similaires pour les régimes cétogène et Atkins modifié, mais ils étaient moins nombreux avec le régime à IG bas
 - Toutefois, le régime cétogène et le régime Atkins modifié ont permis d'obtenir une amélioration des symptômes plus rapidement que le régime IG bas

Resume

Importance : Le régime cétogène (KD) a été utilisé avec succès pour traiter les enfants atteints d'épilepsie résistante aux médicaments. Les données évaluant l'efficacité du régime Atkins modifié (MAD) et du régime à index glycémique bas (LGIT) par rapport au KD sont rares.

Objectif : Déterminer si les régimes MAD et LGIT sont non inférieurs au régime KD chez les enfants atteints d'épilepsie résistante aux médicaments.

Conception, cadre et participants : Cent soixante-dix enfants âgés de 1 à 15 ans qui avaient 4 crises ou plus par mois, n'avaient pas répondu à 2 anticonvulsivants ou plus et n'avaient pas été traités auparavant avec le KD, MAD ou LGIT ont été inscrits entre le 1er avril 2016 et le 20 août 2017 dans un centre de référence pour les soins tertiaires en Inde.

Expositions : les enfants ont été répartis au hasard pour recevoir le régime KD, MAD ou LGIT en complément d'un traitement en cours avec des anticonvulsivants.

Principaux critères de jugement et mesures : le critère de jugement principal était la variation en pourcentage de la fréquence des crises après 24 semaines de traitement diététique dans la cohorte MAD par rapport à la cohorte KD et dans la cohorte régime LGIT par rapport à la cohorte KD. L'essai était alimenté pour évaluer la non-infériorité du régime MAD et LGIT par rapport au KD avec une marge de non-infériorité prédéfinie de -15 points de pourcentage. Une analyse en intention de traiter a été utilisée.

Résultats: Cent cinquante-huit enfants ont terminé l'essai : KD (n = 52), MAD (n = 52) et régime LGIT (n = 54). L'analyse en intention de traiter a montré qu'après 24 semaines d'intervention, la variation médiane (intervalle interquartile [IQR]) de la fréquence des crises (KD : -66 % ; IQR, -85 % à -38 % ; MAD : -45 % ; IQR, -91 % à -7 % ; et régime LGIT : -54 % ; IQR, -92 % à -19 %) était similaire entre les 3 bras (P = 0,39). La différence médiane, par analyse en intention de traiter, dans la réduction des crises entre les bras KD et MAD était de -21 points de pourcentage (IC à 95 %, -29 à -3 points de pourcentage) et entre les bras KD et LGIT était de -12 %, points (IC à 95 %, -21 à 7 points de pourcentage), les deux dépassant la marge de non-infériorité de -15 points de pourcentage. Les événements indésirables liés au traitement étaient similaires entre le KD (31 sur 55 [56,4 %]) et le MAD (33 sur 58 [56,4 %]).

> JAMA pédiatre.1 octobre 2020;174(10):944-951. doi : 10.1001/jamapediatrics.2020.2282.

Efficacité du régime cétogène, du régime Atkins modifié et du régime thérapeutique à faible indice glycémique chez les enfants atteints d'épilepsie résistante aux médicaments : un essai clinique randomisé

Vishal Sondhi¹, Anuja Agarwala², Ravindra M Pandey³, Biswaroop Chakrabarty¹, Prashant Jauhari¹, Rakesh Lodha², Gurudyal S Toteja⁴, Shobha Sharma¹, Vinod K Paul², Eric Kossoff⁵, Sheffali Gulati¹

Affiliations + développer

PMID : 32761191 PMID : PMC7400196 DOI : 10.1001/jamapediatrics.2020.2282

Article PMC gratuit

- **Alimentation et anxiété; un examen de la portée**
 - **Corrélation entre moins d'anxiété**
 - et plus de fruits et légumes, d'acides gras oméga-3, de restriction calorique, de consommation de petit-déjeuner, de régime cétogène, de supplémentation en micronutriments à large spectre, de zinc, de magnésium et de sélénium, de probiotiques et de gamme de composés phytochimiques.
 - **Corrélation entre des niveaux plus élevés d'anxiété**
 - et une alimentation riche en graisses, un tryptophane et des protéines alimentaires inadéquats, une consommation élevée de sucre, de glucides raffinés et des habitudes alimentaires "malsaines"
- **Examen des liens alimentaires et microbiens avec l'alimentation**
 - Les régimes alimentaires de haute qualité, les prébiotiques et les probiotiques peuvent avoir un effet bénéfique sur l'humeur
 - Les régimes alimentaires habituels riches en fibres alimentaires et en acides gras polyinsaturés oméga-3 peuvent être liés à un risque réduit de développer des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress

Résumé

Les troubles anxieux sont le groupe le plus courant de troubles mentaux. Il existe de plus en plus de preuves démontrant l'importance de la nutrition dans le développement et la progression des troubles mentaux tels que la dépression ; Cependant, on en sait moins sur le rôle de la nutrition dans les troubles anxieux. Cet examen de la portée visait à cartographier systématiquement la littérature existante sur les troubles anxieux et la nutrition afin d'identifier les associations entre les facteurs alimentaires et les symptômes d'anxiété ou la prévalence des troubles, ainsi que d'identifier les lacunes et les opportunités de recherches futures. L'examen a suivi des approches méthodologiques établies pour les examens de la portée. En raison du grand volume de résultats, un programme en ligne (Abstrackr) avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle a été utilisé. Les études faisant état d'une association entre un constituant alimentaire et des symptômes ou troubles anxieux ont été comptées et présentées en chiffres. Au total, 55 914 résultats uniques ont été identifiés. Après un examen du texte intégral, 1541 articles répondaient aux critères d'inclusion. L'analyse a révélé une association entre moins d'anxiété et plus de fruits et légumes, d'acides gras oméga-3, de régimes alimentaires "sains", de restriction calorique, de consommation de petit-déjeuner, de régime cétogène, de supplémentation en micronutriments à large spectre, de zinc, de magnésium et de sélénium, de probiotiques et d'un gamme de composés phytochimiques. L'analyse a révélé une association entre des niveaux plus élevés d'anxiété et une alimentation riche en graisses, un tryptophane et des protéines alimentaires inadéquats, une consommation élevée de sucre et de glucides raffinés et des habitudes alimentaires "malsaines". Les résultats sont limités par un grand pourcentage d'études animales et observationnelles. Seulement 10 % des études d'intervention impliquaient des participants souffrant de troubles anxieux, ce qui limite l'applicabilité des résultats. Des études d'intervention de haute qualité impliquant des participants souffrant de troubles anxieux sont justifiées.

Mots clés : anxiété ; diète; diététique; aliments; santé mentale; la nutrition; science nutritionnelle; psychiatrie.

> [Nutriments](#).10 décembre 2021 ;13(12):4418. doi : 10.3390/nu13124418.

Alimentation et anxiété : un examen de la portée

Monique Aucoin¹, Laura Lachance^{2 3}, Umadevi Naidoo^{4 5}, Daniella Rémy^{1 6},
Tanisha Shekdar¹, Négin Sayar¹, Valentina Cardozo¹, Tara Rawana¹, Irina Chan¹,
Kieran Cooley¹ sept 8 9

Affiliations + développer

PMID : 34959972 PMCID : [PMC8706568](#) DOI : [10.3390/nu13124418](#)

[Article PMC gratuit](#)

Les bases du régime hypotoxique

- **Les premiers hominidés ont fait leur apparition sur terre il y a 6 millions d'années**
 - Nos ancêtres se sont surtout nourri des produits de leur chasse et de leur pêche ainsi que de la cueillette de végétaux non cultivés et de miel
 - La nourriture qui provient de l'agriculture et de l'élevage est une innovation qui date seulement de 10 000 ans, ne représente qu'environ 1% de l'histoire de l'être humain.
- Nos enzymes digestives ont évolué en fonction de ce type d'aliments.
 - Nos gènes sont très proches de ceux de nos ancêtres paléolithiques il y a 40000 ans
 - **Nos enzymes seraient mal adaptées à l'alimentation moderne.**
- Chez certaines personnes, l'intestin grêle devient « hyperperméable »
 - Passage dans le sang et les tissus de molécules trop grosses d'origine alimentaire et bactérienne
 - Développement de maladies inflammatoires chroniques

Grands principes

- **Régime qui prône la réduction d'aliments potentiellement toxiques pour le corps,**
 - En particulier ceux qui pourraient participer à l'inflammation, au développement de MAI ou encore aux maladies neurologiques
- **En cessant de manger des aliments qui altèrent l'intestin grêle**
 - Permet aux parois de se reconstituer et de redevenir imperméables aux grosses molécules.
 - Notre système immunitaire pourra ensuite éliminer les toxines accumulées dans nos tissus.
- Le régime «hypotoxique» **ne guérit pas la maladie**, il en permet **la rémission** tant qu'il est respecté.

Les bases du régime hypotoxique

Anthony Berthou, « Du bon sens dans notre assiette », Eds Acte Sud

- **Les premiers hominidés ont fait leur apparition sur terre il y a 6 millions d'années**
 - Nos ancêtres se sont surtout nourri des produits de leur chasse et de leur pêche ainsi que de la cueillette de végétaux non cultivés et de miel
 - La nourriture qui provient de l'agriculture et de l'élevage est une innovation qui date seulement de 10 000 ans, ne représente qu'environ 1% de l'histoire de l'être humain.
- Nos enzymes digestives ont évolué en fonction de ce type d'aliments.
 - Nos gènes sont très proches de ceux de nos ancêtres paléolithiques il y a 40000 ans
 - **Nos enzymes seraient mal adaptées à l'alimentation moderne.**
- Chez certaines personnes, l'intestin grêle devient « hyperperméable »
 - Passage dans le sang et les tissus de molécules trop grosses d'origine alimentaire et bactérienne
 - Développement de maladies inflammatoires chroniques

Grands principes

- **Régime qui prône la réduction d'aliments potentiellement toxiques pour le corps,**
 - En particulier ceux qui pourraient participer à l'inflammation, au développement de MAI ou encore aux maladies neurologiques
- **En cessant de manger des aliments qui altèrent l'intestin grêle**
 - Permet aux parois de se reconstituer et de redevenir imperméables aux grosses molécules.
 - Notre système immunitaire pourra ensuite éliminer les toxines accumulées dans nos tissus.
- Le régime «hypotoxique» **ne guérit pas la maladie**, il en permet **la rémission** tant qu'il est respecté.

Dr Evelyne Bordua Roy, 2^e sommet de la santé métabolique 2024

- **Ces régimes exigent des efforts importants**
- **On supprime:**
 - Les aliments transformés
 - Additifs, conservateurs
 - Les huiles raffinées
 - les céréales modernes considérées comme potentiellement nocives: gluten, lectines
 - Blé, orge, seigle, avoine, maïs et riz
 - les légumes secs,
 - les produits laitiers, en particulier le lait de vache
 - Potentialité à causer des réactions immunitaires
 - les glucides raffinés

1. Le régime GAPS - Gut And Psychology Syndrome - (Syndrome entéro-psychologique)

Le régime GAPS: grands principes

- Protocole conçu par **le Dr Natasha Cambell-McBride**,
 - A fondé la clinique de nutrition de Cambridge,
- **Le régime GAPS, en anglais « GAPS diet »,**
 - Gut And Psychology Syndrome (Syndrome entéro-psychologique)

- Régime alimentaire d'exclusion qui préconise **l'éviction de nombreux aliments** :
 - les produits céréaliers, les légumes secs,
 - le gluten,
 - les produits laitiers
 - les glucides raffinés

Le régime GAPS: Pour qui ? <https://www.neosante.eu/le-syndrome-enteropsychologique/>

- Selon le Dr Natacha Cambell Mc-Bride, le régime GAPS permet **de diminuer les symptômes de maladies neurologiques ou allergies**
 - Les troubles du spectre autistique (TSA),
 - les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H),
 - certains troubles du comportement et de l'apprentissage, la dyspraxie, la dyslexie,
 - la dépression, la schizophrénie, le syndrome de la Tourette, la bipolarité
 - certains troubles du comportement alimentaire
 - les allergies, l'asthme, et l'eczéma

- Les adultes et les enfants atteints du **syndrome entéro-psychologique** souffrent généralement de troubles digestifs, parfois graves
 - Coliques, ballonnements, flatulences, diarrhées, constipation, candidoses, allergies difficultés à ingérer des aliments et malnutrition
- La théorie repose sur le fait que **les maladies neurologiques surviennent suite à une trop grande perméabilité des intestins** liée à un **dysfonctionnement du système digestif**
 - Cette perméabilité intestinale entraînerait l'intrusion de bactéries et de substances chimiques toxiques de notre alimentation dans la circulation sanguine.
 - Ces substances affecteraient le système nerveux et provoqueraient les maladies qui découlent de ces anomalies.
 - Le régime **GAPS permettrait de guérir l'intestin** en prévenant l'irruption des toxines dans la voie sanguine.
- **Le protocole GAPS vise à**
 - Détoxifier le patient, dissiper le «brouillard» toxique qui empêche le cerveau de se développer et de fonctionner correctement
 - Nettoyer et soigner le système gastro-intestinal afin qu'il cesse de constituer la principale source d'intoxication de l'organisme et qu'il remplisse sa fonction, à savoir nourrir l'organisme
 - Les substances toxiques véhiculées par notre sang (et qui pénètrent dans le cerveau) étant à plus de 90% issues des intestins, le traitement des intestins fait chuter de manière spectaculaire le niveau de toxicité de l'organisme.

Phase d'introduction: Arrêt des aliments qui perturbent la digestion

Toutes les céréales et les aliments fabriqués à partir de céréales (ou assimilées)
: éliminer le gluten et l'amidon

- *blé, seigle, riz, avoine, maïs, sorgho, sarrasin, millet, épeautre, triticale, boulgour, tapioca, quinoa,*

Tous les féculents et aliments produits à base de féculents

- *pomme de terre, igname, patate douce, panais, topinambour, manioc, arrow-root*

Les légumes secs

- *soja, haricots mungo, pois chiches, fèves, lentilles*

Le sucre sous toutes ses formes et tout ce qui en contient

Le lactose et tout ce qui en renferme

- *lait, yaourt, beurre, crème fraîche, et autres desserts lactés*



Phase d'introduction

- Cette diète d'introduction permet de **réduire au silence tous les symptômes digestifs, en réparant la paroi de l'intestin**
- Puis on **réintroduit progressivement** les aliments selon des étapes précises
 - Cette opération délicate doit se faire de façon progressive et se divise en six étapes.
 - Il est demandé aux patients d'être vigilants sur les signes digestifs éventuels de non-tolérance.
 - Cette phase peut durer **entre 3 semaines et un an** en fonction des ressentis et de la tolérance du patient.

Phase d'introduction: Étape 1 <https://www.goodsesame.com/blog/le-regime-gaps/>

- **Acclimater son organisme** en consommant entre les repas :
 - Des bouillons d'os de viande maison,
 - Des aliments riches en probiotiques, aliments lacto-fermentés
 - 1 à 5 cuillères à café par jour
 - Du gingembre en infusion, thé à la menthe ou à la camomille aromatisé au miel.
 - Des yaourts ou du kéfir faits maison



Phase d'introduction: Étape 2

<https://www.goodsesame.com/blog/le-regime-gaps/>

- On ajoute
 - Des jaunes d'œuf crus biologiques (un par jour puis 1 par bol de soupe)
 - Des ragoûts de légumes avec de la viande à forte teneur en graisse
 - Du poisson fermenté
 - Du ghee maison
 - 1 cuillère à café par jour, puis augmenter les doses



Phase d'introduction: Étape 3

<https://www.goodsesame.com/blog/le-regime-gaps/>

- On ajoute:
 - De l'avocat écrasé dans les soupes
 - De la choucroute et des légumes fermentés,
 - De la graisse de canard, d'oie (en plus du ghee)
 - Des oignons frits dans du ghee ou graisse de canard
 - Des crêpes,
 - avec purée d'oléagineux, œufs, morceau de courge ou de courgette fraîche (pelée, épépinée et bien mixée)
 - légèrement frites dans du ghee ou graisse de canard



Phase d'introduction: Étape 4

<https://www.goodsesame.com/blog/le-regime-gaps/>

- On ajoute:
 - De la viande grillée,
 - Des légumes cuits et légumes fermentés
 - Des jus de fruits et légumes fraîchement pressés et filtrés
 - De l'huile d'olive vierge extra pressée à froid,
 - Du « pain maison »
 - avec des amandes ou autres oléagineux, farine d'amande, œufs, potiron, courge ou courgette (pelée, épépinée et finement émincée),
 - ghee ou graisse de canard, sel



Phase d'introduction: Étape 5

<https://www.goodsesame.com/blog/le-regime-gaps/>

- On ajoute:
 - De la compote de pommes maison
 - avec ajout de ghee ou graisse de canard
 - Des crudités douces : laitue, concombre pelé,
 - **Observer les selles**
 - D'autres légumes crus; carottes, tomates, oignons, choux
 - Des fruits ajoutés aux jus de légumes: pommes, ananas, mangues,
 - Pas d'agrumes



Phase d'introduction: Étape 6

<https://www.goodsesame.com/blog/le-regime-gaps/>

- On ajoute:
 - De la pomme crue, pelée, augmentation progressive de fruits crus
 - Des pâtisseries maison en sucrant les pâtisseries avec des fruits secs
- Ce régime préliminaire sera maintenu plus ou moins longtemps **selon l'évolution des selles**
 - **Attendre que les diarrhées s'atténuent**
 - L'introduction de certains aliments peut être différée en fonction des sensibilités particulières
 - Maintenir soupes et bouillons au moins une fois par jour à l'issue du régime préliminaire



Phase deux : Partie centrale du régime GAPS

Partie centrale du régime GAPS

- C'est dans cette période que les patients suivent à la lettre les préceptes du protocole. Sa durée est équivalente à 2 ans.
- **Conseille la consommation**
 - de viande fraîche sans hormone, de poissons (non fumés), de crustacés, d'œuf biologiques,
 - de graisses animales (ghee, canard ou oie) et végétales (olive, coco)
 - d'aliments fermentés (kéfir, lacto-fermentés), de yaourts maisons,
 - de légumes frais (avec peu d'amidon), d'avocat, de fruits cuits et crus
 - fruits à coque et graines trempées et déshydratées
 - de l'ail tous les jours
 - le miel est le seul aliment sucré autorisé
 - le régime GAPS a aussi créé des recettes de « pancakes » et de « pain » à base de farine de noix de cajou comme alternatives aux produits céréaliers interdits.

JOURNÉE RÉGIME GASP

Verre d'eau chaude.

Bol de yaourt maison ou de kéfir. Verre de jus de fruits/légumes

Petit déjeuner vers 10h

Variante du petit déjeuner anglais : oeufs cuits accompagnés de saucisses et de légumes.

Avocat avec des restes de viande, de poisson ou des coquillages, légumes crus et cuits, citron et huile d'olive pressée à froid. Servez le tout avec une tasse de bouillon de viande chaud, sans oublier d'ajouter des aliments probiotiques.

Des crêpes épaisses façon "pancakes", à base de farine d'oléagineux avec du beurre, de la crème aigre . Des baies, fraîches ou décongelées et mixées dans du miel



Dîner

Soupe de légumes maison ou ragoût dans un bouillon de viande maison.

Avocat en accompagnement des viandes, poissons, fruits de mer et légumes cuits et/ou crudités. Assaisonnez d'huile d'olive et de citron et servez en boisson une tasse de bouillon de viande chaud avec un peu de yoghourt/kéfir.

N'importe quel plat de viande/poisson accompagné de légumes.

Souper

L'un des plats servis au déjeuner ou au petit-déjeuner.

Après le dîner, une demi-tasse de yogourt ou kéfir.

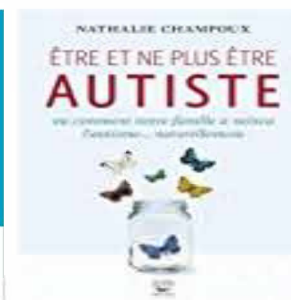
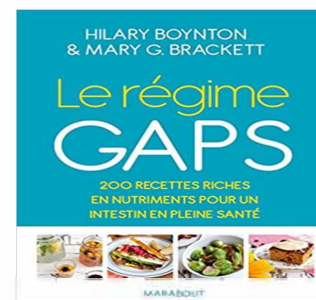
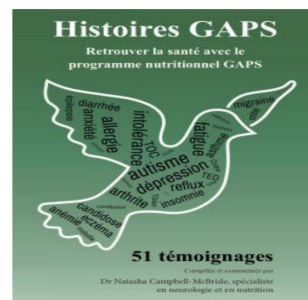
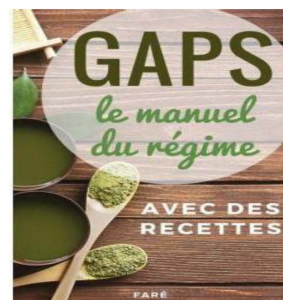
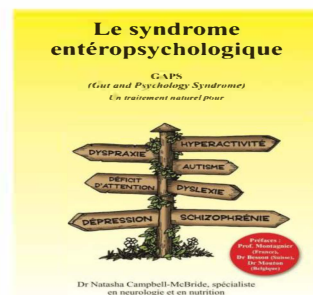
Phase de réintroduction alimentaire

- Ne peut se prolonger au-delà de 2 ans, du fait de son caractère restrictif
- Tout comme la phase d'introduction, il faut ensuite réintroduire les aliments de façon progressive
- Il n'y a pas d'ordre spécifique, le tout est de rester attentif aux signes digestifs d'intolérance
- Une fois la phase de réintroduction terminée, certains produits ne doivent plus être consommés
 - les produits industriels
 - les glucides raffinés

Points faibles, points forts du régime GASP

Lanutrition.fr

RÉGIME	GASP
Points forts	Progression très individualisée Prévention de l'autisme Réduit au silence les symptômes de nombreuses maladies
Points faibles	Restrictif, très contraignant, difficile à suivre Attention aux carences Besoin d'un accompagnement (naturopathe, diététicien)
Recommandations	Pas d'article scientifique Pas de recommandations hormis celles de Natacha Cambell Mc-Bride Sur le plan empirique, les données s'accumulent. Beaucoup de parents d'autistes semblent le trouver quasi-miraculeux Certaines personnes l'utilisent aussi dans le traitement de la maladie de Lyme chronique, à l'instar de Judith Albertat



2. Le régime anti-inflammatoire

- **Le régime anti-inflammatoire**
 - Conjugue le meilleur du régime méditerranéen de la Crête et du régime japonais d'Okinawa, tous deux associés à une meilleure santé et à une plus grande longévité.
- Le **Dr Andrew Weil**, Pr de médecine, Dr du programme de médecine intégrée à l'Université d'Arizona,
- Le **Dr Jean Seignalet**: De l'Alimentation à la 3^e médecine
- Les **Dr David Servan-Schreiber** et la **Dre Serfaty-Lacroix**
- Ont mis au point un régime alimentaire qualifié de "**régime anti-inflammatoire**".
- **Jacqueline Lagacé** et son témoignage dans son livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation » et son blog
- A suivi les recommandations du Dr Jean Seignalet (prochain cours d'Irène)

Régime anti-inflammatoire : Grands principes

- **Objectifs**
 - Réduire l'inflammation pour réduire la douleur et les symptômes des maladies auto-immunes
- **Réduire la consommation d'aliments potentiellement toxiques pour le corps**
 - Aliments qui pourraient contribuer à l'inflammation et aux maladies auto-immunes
 - Céréales modernes: blé, orge, seigle, avoine, maïs, riz
 - Gluten
 - Lectines
 - Produits laitiers: lait de vache
 - Réactions immunitaires
 - Aliments ultra-transformés
 - Additifs alimentaires, conservateurs

- **Régime très restrictif**
 - Mais quand on cesse de souffrir, qu'on retrouve la santé et la capacité de se mouvoir normalement, ces privations ne comptent plus
 - Et même si on doit adopter ce régime pour le reste de notre vie, on peut s'offrir quelques écarts à l'occasion.

Régime anti-inflammatoire : Pour qui ?

- **Les personnes qui souffrent de**
 - Douleurs chroniques
 - Inflammation
 - Maladies auto-immunes
- **L'inflammation est l'une des causes communes des maladies**
 - Des maladies cardiovasculaires,
 - Du diabète
 - Des douleurs ostéo-articulaires
 - Des pathologies auto-immunes
 - De certains cancers

Principes du régime anti-inflammatoire

- Équilibrer l'apport quotidien de protéines, glucides, lipides et fibres
 - **Glucides**
 - 40 % à 50 % de l'apport calorique quotidien
 - **Lipides**
 - 30 % des calories quotidiennes
 - 25 % acides gras saturés, 25 % Ags polyinsaturés, 50 % Ags mono insaturés
 - **Protéines**
 - 80 g à 120 g chaque jour
 - plus de végétaux et moins de viandes ou poissons, des produits laitiers faibles en matières grasses et des produits à base de soja
 - **Fibres**
 - 40 g chaque jour (fruits, légumes)

Les aliments à recommander

- **La betterave**
 - bétanine et caroténoïdes.
- **Le céleri**
 - poly-acétylènes aux vertus anti-inflammatoires et antibactériennes
 - Atténuent les douleurs favorisent l'élimination des toxines de l'organisme



- **Les condiments**
 - Ails, oignons: allicine, composé soufré aux vertus anti-inflammatoires
- **Les épices et aromates**
 - cannelle, poivre noir, curry , gingembre, curcuma, origan, laurier, romarin
- **Les agrumes:** (*citron, orange, pamplemousse...*)
 - Teneurs intéressantes **en vitamine C et en bioflavonoïdes**
- **L'ananas**
 - bromélaïne composé antioxydant et anti-inflammatoire naturel
- **Favoriser la cuisson douce**
 - Cuisson à basse température pour préserver les nutriments des aliments
- **Individualisation**
 - Des ajustements alimentaires peuvent être nécessaires en fonction des intolérances et des réactions spécifiques

Les aliments à proscrire

Les aliments transformés,



Les aliments acidifiants

Les viandes rouges,
charcuteries,
Les produits raffinés



Les produits laitiers

de vache, de brebis ou
de chèvre, (caséine)



Le gluten

blé, seigle, orge,
avoine,...



Le sucre



Les alcools

Le point de vue de la recherche

- **Essai croisé randomisé lancé en 2018 par l' Université de Göteborg en Suède**
- Effets d'un **régime anti-inflammatoire** sur l'activité de la maladie et la qualité de vie dans la polyarthrite rhumatoïde :
 - Le protocole d'étude ADIRA (*Régime anti-inflammatoire dans la polyarthrite rhumatoïde*)
- **50 patients atteints de PR** ont reçu, concomitamment avec leur traitement médicamenteux
 - une alimentation riche en fibres, en poisson et en probiotiques représentant 50 % de l'apport quotidien, 5 jours par semaine, pendant 10 semaines
 - 4 mois de sevrage
 - une alimentation riche en protéines, viande rouge et graisses saturées représentant 50 % de l'apport quotidien, 5 jours par semaine, pendant 10 semaines
- En résultat: **Effets positifs d'un régime anti-inflammatoire** proposé sur l'activité de la maladie chez les patients atteints de PR.
 - Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ce régime peut entraîner des améliorations cliniquement pertinentes

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648598/>

Effets sur la qualité de vie liée à la santé dans l'essai croisé randomisé et contrôlé ADIRA (régime anti-inflammatoire dans la polyarthrite rhumatoïde)

Anna Turesson Wadell ¹, Linnea Bärebring ¹, Erik Hulander ¹, Inger Gjerdtsson ², Lars Hagberg ³, Helen M Lindqvist ¹, Anna Winkvist ¹

Affiliations + développer

PMID : 34648598

PMCID : [PMC8516209](#)

DOI : [10.1371/journal.pone.0258716](#)

Article PMC gratuit

[Liens plein texte](#)

[Citer](#)

...



Résumé

Contexte : Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) signalent souvent une altération de la qualité de vie liée à la santé (HrQoL) telle que des difficultés dans la vie quotidienne, des douleurs, de la fatigue et une vie sociale affectée. Même en diminuant l'activité de la maladie, le traitement pharmacologique ne résout pas toujours ces facteurs.

Objectif : Étudier si un régime anti-inflammatoire proposé améliore la HrQoL chez les patients atteints de PR.

Conception : Dans cet essai croisé contrôlé, 50 patients ont été randomisés pour commencer soit par un régime d'intervention (anti-inflammatoire) soit par un régime témoin (apport suédois habituel) pendant dix semaines, suivi d'une période de sevrage avant de passer à l'autre régime. Les participants ont reçu une nourriture équivalente à ~1100 kcal/jour, cinq jours/semaine, et des instructions pour consommer de la même manière pour les repas restants. La HrQoL a été évaluée à l'aide du questionnaire d'évaluation de la santé (HAQ), d'une enquête abrégée en 36 items (SF-36), d'échelles visuelles analogiques (EVA) pour la douleur, la fatigue et la raideur matinale, et d'une échelle de temps pour la raideur matinale.

Résultats : Quarante-sept participants ont terminé ≥ 1 période de régime et ont été inclus dans les analyses principales. Aucune différence significative entre le régime d'intervention et le régime de contrôle à la fin des périodes de régime n'a été observée pour aucun résultat. Cependant, des améliorations significatives ont été obtenues pour le fonctionnement physique du SF-36 (moyenne : 5,79, SE : 2,12, IC à 95 % : 1,58, 10,01) pendant la période de régime d'intervention. En excluant les participants avec des changements de médicaments anti-rhumatismaux, les différences entre les périodes de régime ont augmenté pour la plupart des résultats, favorisant la période de régime d'intervention, et la différence pour le fonctionnement physique SF-36 est devenue significative ($n = 25$, moyenne : 7,90, IC à 95 % : 0,56, 15,24, $p = 0,036$).

Conclusions : Dans les principales analyses, le régime anti-inflammatoire proposé n'a pas amélioré de manière significative la qualité de vie des patients atteints de PR par rapport au régime témoin. Dans les sous-analyses, des améliorations significatives du fonctionnement physique ont été détectées. Des études plus importantes avec une utilisation régulière des médicaments et dans des populations plus touchées par la maladie peuvent être nécessaires pour obtenir des preuves concluantes.

Indice inflammatoire alimentaire et paramètres de risque cardiométabolique chez les sujets en surpoids et sédentaires

Claudia Marcela Camargo-Ramos ¹, Jorge Enrique Correa-Bautista ², María Correa-Rodríguez ³, Robinson Ramírez-Vélez ⁴

Affiliations + développer

PMID : 28984835 PMCID : PMC5664605 DOI : 10.3390/ijerph14101104

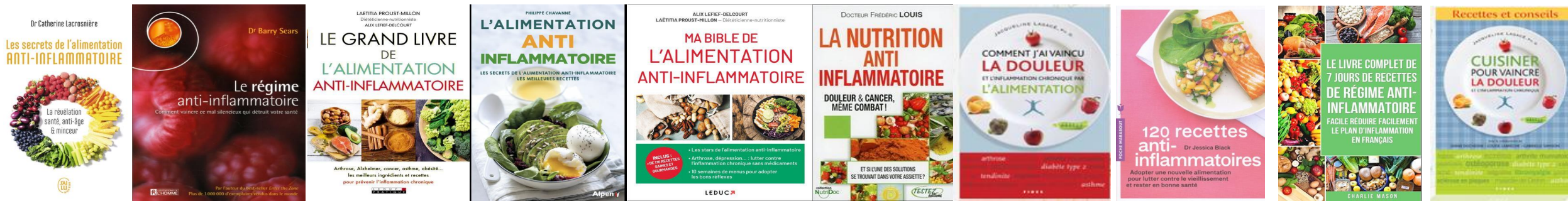
Article PMC gratuit

La nutrition a été établie comme un facteur pertinent dans le développement des maladies cardiovasculaires (MCV). Nous avons cherché à étudier la relation entre l'indice inflammatoire alimentaire (DII) et les paramètres de risque cardiométabolique dans une cohorte de 90 adultes en surpoids et sédentaires de Bogotá, en Colombie. Un enregistrement alimentaire de 24 heures a été utilisé pour calculer le DII. Les variables de composition corporelle, la dilatation médiée par le flux (FMD), la vitesse de l'onde de pouls (PWV), le profil lipidique, le glucose, l'hémoglobine glycosylée (Hb1Ac) et la pression artérielle ont été mesurés et un score de risque cardiométabolique (MetScore) a été calculé. Un score DII inférieur (régime anti-inflammatoire) était significativement associé à un taux de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL-C) et à une fièvre aphteuse plus élevés, ainsi qu'à une baisse de l'Hb1Ac et du MetScore ($p < 0,05$). Un score DII inférieur était inversement corrélé aux taux plasmatiques de triglycérides ($r = -0,354, p < 0,05$), au glucose ($r = -0,422, p < 0,05$), au MetScore ($r = -0,228, p < 0,05$) et à la PWV ($r = -0,437, p < 0,05$), et positivement avec la fièvre aphteuse ($r = 0,261, p < 0,05$). En revanche, un score DII plus élevé (régime pro-inflammatoire) a montré une relation positive avec le MetScore ($r = 0,410, p < 0,05$) et une relation négative avec la fièvre aphteuse ($r = -0,233, p < 0,05$). Un potentiel inflammatoire accru du régime alimentaire était inversement associé à un profil cardiométabolique amélioré, ce qui suggère l'importance de promouvoir les régimes anti-inflammatoires comme stratégie efficace de prévention des MCV.

Mots clés : cardio-métabolique ; diète; index inflammatoire alimentaire; en surpoids.

Régimes anti-inflammatoires
Stratégie efficace des maladies
cardiovasculaire

RÉGIME	ANTI-INFLAMMATOIRE
Points forts	Équilibre alimentaire respecté: alimentation fraîche, pas de produits transformés Rassasiant: aucun problème de satiété Fonctionne relativement rapidement Prévention des maladies cardiovasculaires
Points faibles	Nouvelles techniques de cuisson: basse température Exclusion de nombreux aliments Peut perturber le transit intestinal (fibres)
Recommandations Passeportsante.net	Ce régime, largement inspiré du régime méditerranéen, permet de réduire les risques de contracter une maladie cardiovasculaire ou une maladie inflammatoire chronique. Il est facile à suivre et est équilibré puisque aucun groupe alimentaire n'est totalement mis de côté il s'agit plutôt de fréquences de consommation à respecter.



3. Le protocole AIP Protocole auto-immun

Protocole AIP : Pour qui ?

- **Les personnes qui souffrent**
 - de MAI
 - de lupus,
 - de polyarthrite rhumatoïde,
 - de psoriasis
 - de vitiligo
 - de MICI,
- **Objectifs**
 - Réduire l'inflammation, la douleur et d'autres symptômes causés par des maladies auto-immunes

Grands principes

- **Un système immunitaire sain** est conçu pour produire des anticorps qui attaquent les cellules étrangères ou nocives de notre organisme
- Chez les personnes atteintes de **MAI**, le **système immunitaire a tendance à produire des anticorps qui**, plutôt que de combattre les infections, **attaquent les cellules et les tissus sains**
- Cela entraîne une série de symptômes, notamment
 - **des douleurs articulaires,**
 - **de la fatigue,**
 - **des douleurs abdominales, de la diarrhée,**
 - **un brouillard cérébral**
 - **des lésions tissulaires et nerveuses**

- **Ressemble au régime paléo** à la fois dans les types d'aliments autorisés et évités, ainsi que dans les phases qui le composent.
 - En raison de leurs similitudes, beaucoup considèrent le protocole AIP comme une extension du régime paléo – bien que l'AIP puisse être considéré comme une version plus stricte de celui-ci
- Élimination des **aliments responsables de l'hyperperméabilité intestinale**
- Remplacement par des **aliments favorisant la santé et riches en nutriments** qui sont censés **aider à guérir l'intestin** et, finalement, à réduire l'inflammation et les symptômes des maladies auto-immunes
- Met également l'accent sur **l'amélioration des facteurs liés au mode de vie, tels que le stress, le sommeil et l'activité physique** .

LES PILIERS DE L'AIP EN RÉSUMÉ

Alimentation

- Manger des aliments riches en nutriments
- Éliminer les aliments inflammatoires
- Réintroduire les aliments un à un et observer
- Adoption définitive d'un régime alimentaire personnalisé (parce que chacun est unique)



Style de vie

- Gérer son stress
- Gérer son sommeil
- Se connecter à la nature, à soi-même, aux autres
- Pratiquer des activités physiques
- Réduire les toxines

- **Élimination des aliments susceptibles de provoquer**

- une inflammation intestinale,
- des déséquilibres entre les niveaux de bonnes et de mauvaises bactéries dans l'intestin,
- une réponse immunitaire

- les céréales, les légumineuses, les noix, les graines,
- les œufs et les produits laitiers
- Le tabac, l'alcool, le café,
- les huiles raffinées,
- les additifs alimentaires,
- les sucres raffinés et transformés
- Certains médicaments, anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS



- Encourage la consommation
 - de viande fraîche, peu transformée,
 - d'aliments fermentés
 - et de bouillon d'os.
- La durée de la phase d'élimination du régime est généralement maintenue jusqu'à ce que la personne ressente une réduction notable des symptômes.
- En moyenne, la plupart des gens maintiennent cette **phase pendant 30 à 90 jours**, mais certains peuvent remarquer des améliorations dès les 3 premières semaines .

Phase de réintroduction

- Au cours de cette phase, les aliments évités sont **progressivement réintroduits dans l'alimentation**, un à la fois, en fonction de la tolérance de la personne.
- Le but de cette phase est
- D'identifier **quels aliments contribuent aux symptômes d'une personne**
- De **réintroduire tous les aliments qui ne causent aucun symptôme**
- De **continuer à éviter tous les aliments qui causent des symptômes.**



Étape 1. Choisissez un aliment à réintroduire.

Consommez cet aliment **plusieurs fois par jour le jour du test**, puis évitez-le complètement pendant 5 à 6 jours.



Étape 2. Mangez une petite quantité, équivalente à 1 cuillère à café de l'aliment,

Attendez 15 minutes pour voir si vous avez une réaction



Étape 3. Si vous ressentez des symptômes, mettez fin au test et évitez cet aliment. Si vous ne présentez aucun symptôme, mangez une portion légèrement plus grande, comme 1 1/2 cuillère à soupe, du même aliment et surveillez ce que vous ressentez pendant 2 à 3 heures.

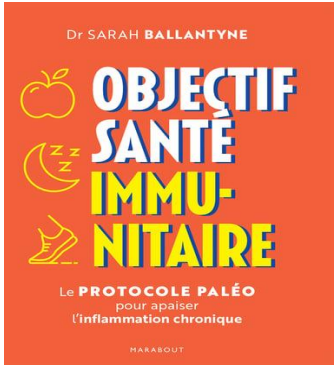
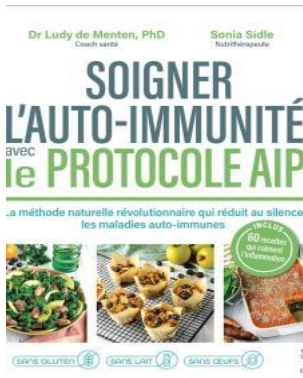


Étape 4. Si vous ressentez des symptômes pendant cette période, mettez fin au test et évitez cet aliment. Si aucun symptôme n'apparaît, mangez une portion normale du même aliment et évitez-le pendant 5 à 6 jours sans réintroduire d'autres aliments.



Étape 5. Si vous ne ressentez aucun symptôme pendant 5 à 6 jours, vous pouvez réincorporer l'aliment testé dans votre alimentation. Répéter ce processus de réintroduction en 5 étapes avec un nouvel aliment.

RÉGIME	PROTOCOLE AIP
Points forts	Il aide à réduire l'inflammation dans le corps Il améliore l'intégrité de la barrière intestinale Il augmente les bactéries bénéfiques du microbiote intestinal Il permet d'identifier les aliments qui déclenchent des symptômes Il diminue les symptômes de maladies auto-immune
Points faibles	Exclusion de nombreux aliments Assez contraignant
Recommandations	Ce régime, largement inspiré du régime paléo, permet de réduire les symptômes dues aux maladies inflammatoires chroniques



Introduction et objectif : Dans le monde scientifique, les besoins nutritionnels des personnes atteintes de la maladie thyroïdienne auto-immune de Hashimoto sont discutés, et il y a beaucoup d'intérêt pour le protocole auto-immun (AIP). L'objectif de l'étude était de vérifier les effets de l'AIP sur les paramètres thyroïdiens chez les patients euthyroïdiens atteints de la maladie de Hashimoto.

Matériel et méthodes : Parmi 28 personnes atteintes de la maladie de Hashimoto (dont 1 homme), la consommation de nutriments, l'anthropométrie, les symptômes de la maladie, les valeurs des paramètres thyroïdiens : FT3, FT4, TSH, échographie thyroïdienne et aTPO auto-immune, aTG ont été analysés avant et après 12 semaines d'utilisation du régime AIP. L'impact des changements dans la consommation de certains nutriments sur les changements dans les paramètres biochimiques de la thyroïde a été analysé à l'aide de modèles de régression multiple, où les variables dépendantes des modèles créés étaient les changements dans les paramètres biochimiques de la thyroïde.

Résultats: Après l'application du régime AIP, le nombre de personnes signalant des symptômes de malaise a diminué, les niveaux de FT3 et FT4 ainsi que de TSH ont diminué, restant dans la plage de concentration de référence. L'aTG a légèrement diminué, mais l'aTPO a augmenté de manière significative. L'échographie a également montré une diminution du volume de la glande thyroïde. Le poids corporel des sujets a diminué, ce qui indique un déficit calorique.

Conclusions: Compte tenu des nombreux avantages du régime AIP, l'allongement du temps d'observation du régime, ainsi que sa personnalisation en termes de sélection alimentaire, d'énergie et de valeur nutritionnelle, pourraient montrer des changements à la fois dans le bien-être et les résultats des tests biochimiques dans une plus grande mesure. L'utilisation d'un protocole AIP personnalisé peut améliorer la qualité de vie, un changement positif de l'état mental, une réduction du stress et, surtout, l'amélioration des affections indésirables associées à la maladie de Hashimoto.

Mots-clés: Protocole auto-immun ; la maladie de Hashimoto ; apport en nutriments ; paramètres thyroïdiens.

> [Ann Agric Environ Med](#). 2023 Sep 28;30(3):513-521. doi: 10.26444/aaem/166263. Epub 2023 Jun 1.

Effects of Autoimmune Protocol (AIP) diet on changes in thyroid parameters in Hashimoto's disease

[Paulina Ihnatowicz](#) ¹, [Jerzy Gębski](#) ¹, [Małgorzata Ewa Drywień](#) ¹

Affiliations + expand
PMID: 37772528 DOI: [10.26444/aaem/166263](#)
[Free article](#)

4. Le protocole Wahls

- Terry Wahls, professeure de médecine de l'université de l'Iowa, diagnostiquée avec la sclérose en plaques (SEP) en 2000. En 2003, elle a dû se résoudre au fauteuil roulant.
 - Maladie qui s'aggrave généralement avec le temps.
 - Le système immunitaire attaque le système nerveux, ce qui peut altérer la motricité, la vue, la parole.
- A partir de 2004, le Pr Wahls a recueilli et analysé des centaines d'études sur le lien entre **l'alimentation et la physiologie du système nerveux**.
- **Elle en a conçu un régime alimentaire avec des suppléments nutritionnels, inspiré du régime Paléolithique**
- À l'automne 2007, elle a mis son nouveau protocole à l'essai, en jouant elle-même le rôle de cobaye
 - En trois mois, sa fatigue avait disparu. En six mois, elle marchait sans cannes, et en neuf mois, elle se déplaçait à vélo

Protocole Wahls: Pour qui ?

- **Destiné aux personnes atteintes de MAI, en particulier la sclérose en plaques (SEP)**
- **Objectifs**
 - Réduire l'inflammation pour diminuer les symptômes et stabiliser la SEP

Protocole Wahls: Grands principes

- **Réduction de la consommation d'aliments potentiellement toxiques pour l'organisme**

- Céréales raffinées
- Produits laitiers
- Sucres ajoutés
- Aliments transformés
 - Additifs alimentaires, conservateurs
 - Huiles raffinées

- **Réduction des toxines environnementales**

- Produits de soins personnels et ménagers non toxiques

- **Alimentation riche en nutriments**

- Légumes à feuilles vertes, crucifères,
- Les baies
- Les viandes maigres
- Les poissons gras
- Les huiles végétales de 1ère pression à froid
- Les noix, les graines

- **Supplémentation pour soutenir la santé cérébrale et le système immunitaire**

- Vitamine D
- Vitamine B12
- Oméga 3
- Magnésium
- Glutathion



- Le protocole Wahls comporte de 3 niveaux
 - **Les niveaux 1 et 2 incluent trois repas par jour, avec des options de collation**
 - **Le niveau 3 recommande de manger deux repas par jour** et de jeûner pendant 12 à 16 heures chaque nuit
- Un ajout au protocole Wahls, appelé **le régime d'élimination Wahls**, peut être utilisé à l'un des trois niveaux
 - Il supprime les **solanacées** (tomates, pommes de terre, aubergines et poivrons), et les graines d'épices pendant 100 jours, puis les réintroduit une par une

Points faibles, points forts du protocole Wahls Lanutrition.fr

RÉGIME	ANT I-INFLAMMATOIRE
Points forts	Aliments frais sains et variés, riches en nutriments
Points faibles	Complexe, très restrictif Nécessite un coaching et un accompagnement
Recommandations	En France Julien Venesson a adapté le protocole Wahls pour sa compagne atteinte de SEP (voir son livre: Vaincre la Sclérose en Plaques)

Résumé

Bien qu'il n'existe pas de schéma alimentaire supérieur à celui qui s'est avéré efficace pour réduire le nombre de poussées ou augmenter les lésions chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP), plusieurs études pilotes ont démontré l'efficacité des plans diététiques pour réduire les symptômes liés à la SEP. Les graisses saturées faibles (Swank), les faibles graisses végétaliennes (McDougall), le Paléolithique modifié (Wahls), le sans gluten, la Méditerranée, le jeûne intermittent, la restriction calorique et la restriction calorique intermittente (alimentation en fermetage) ont tous été associés à la réduction des symptômes liés à la SEP tels que la réduction de la fatigue, l'amélioration de l'humeur et l'amélioration de la qualité de vie. Le régime méditerranéen s'est avéré efficace pour la prévention et la réduction de la sévérité de la maladie comorbide.

Mots clefs: Limites caloriques; Faiblesse; Régime pauvre en graisses saturées; Régime méditerranéen; Sclérose multiple; Régime paléolithique; Régime Swank; Régime Wahls.

Copyright - 2022 Elsevier Inc. Tous droits réservés.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35989054/>

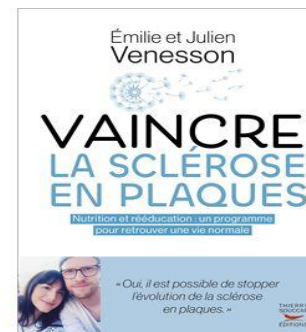
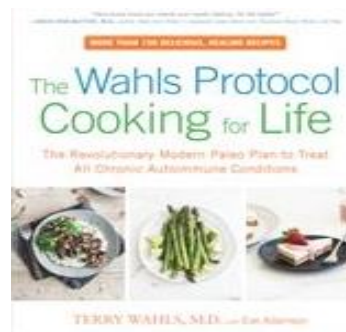
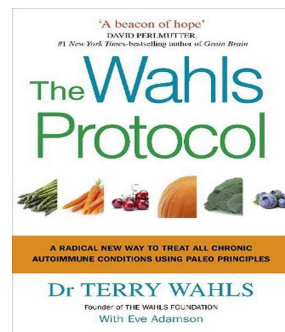
Review > Phys Med Rehabil Clin N Am. 2022 Aug;33(3):605-620. doi: 10.1016/j.pmr.2022.04.004. Epub 2022 Jun 25.

Dietary Approaches to Treating Multiple Sclerosis-Related Symptoms

Terry L Wahls¹

Affiliations + expand

PMID: 35989054 DOI: 10.1016/j.pmr.2022.04.004



Type de diète	Cible	Aliments éliminés
Atkins	Syndrome métabolique Dépression, anxiété	Réduction des glucides, féculents, fruits sucrés Boissons sucrées Aliments ultra transformés Boissons sucrées
Cétogène	Syndrome métabolique Épilepsie Dépression, anxiété	
GASP	Autisme Déficit d'attention	Produits AUT Huiles raffinées Céréales Légumineuses Produits laitiers Glucides raffinés Aliments acidifiants Gluten Noix graines œufs
Anti-inflammatoire	Auto-immunité Douleurs chroniques	
Protocole AIP	Auto-immunité	
Protocole Wahls	SEP	Céréales, Gluten, Produits AUT Produits laitiers Sel